

בירור על הרקע רפואי:

- האם מדובר באירוע ראשון?
- האם יש הפרעות מטבוליות, נירולוגיות או קרדיווסקולריות?
- שימוש בתרופות ובחומרים מסוכנים

דגשים כלליים לטיפול בעילפון

- ראשית יש לתמוך ב-ABC
- בדיקת רמות גלוקוז
- אק"ג
- אם אפשר, בדיקת חום
- בדיקה נירולוגית מדוקדקת
- יש לחשוד שיש ACS, דיסקציה ותסחיף ריאות (PE) בכל מטופל עם עילפון, בייחוד אלו המלינים על כאבים עזים בחזה
- לשלול TBI
- לשלול חתכים בעור או חבלות נוספות

כאבי ראש

תלונה על כאבי ראש היא תלונה נפוצה מאוד. לכ־80% מהאוכלוסייה יהיה כאב ראש לפחות פעם בשנה. כ־90% מכלל כאבי הראש מסווגים ככאבי ראש ראשוניים (primary headache), כלומר כאבים שבהם הגורם האטיולוגי אינו ברור. כאבי ראש ראשוניים כוללים מיגרנות, כאב ראש ממתח (tension headache) וכאב ראש מקבצי (cluster headache). כאבי ראש ראשוניים אינם מסוכנים לחיים, אך נוטים לכאוב בצורה משמעותית, עד כדי פגיעה גדולה באיכות החיים.

כאב ראש ראשוני (Primary Headache)

כמעט בכל המקרים, כאבי ראש ראשוניים מוכרים למטופל מאירועים קודמים.

- כאב מיגרנוטי בדרך כלל מתבטא ככאב חד־ציד (ב־40% מהמקרים דו־ציד), שנמצא באזור הרקות, והוא בדרך כלל מתואר ככאב פועם. תרופות קו ראשון למיגרנות הן NSAIDs (נוגדי דלקת שאינם סטרואידים; nonsteroidal anti-inflammatory drugs: NSAID), ואם תרופות אלה אינן מצליחות להפחית את הכאב, אפשר להשתמש בתרופות ספציפיות למיגרנות.
- כאב ראש מתחי, תעוקתי (tension headache) - בדרך כלל מתואר כלוחץ, דו־ציד וולעיתי דמוי טבעת. מלווה במתח בשרירי הצוואר.
- כאב ראש מקבצי (cluster headache) - בדרך כלל מתייצג ככאבים חזקים מאוד, חד־צידיים, באזור אחת העיניים (בדרך כלל מעל העין) ונמשך שעות. כאבים אלו לא נוטים להגיב לטיפול תרופתי, אך הם כן מגיבים למתן חמצן. אם יש אירוע אקוטי, יש לתת חמצן בקצב גבוה 10-15LPM עד לחלוף הכאבים (כ־15 דקות).

כאב ראש משני

כאבי ראש משניים כוללים כאבים שהגורם להם ידוע, והטיפול בגורם מביא להיעלמות הכאב. בקבוצה זו: כאבים הנובעים מהסינוסים, ממבנים צוואריים, ממבנים בלסת, מדימומים תוך-גולגולתיים, מגידולים או מכאבים הקשורים למבנה הפנים (עיניים, שיניים, שרירים ועצבי הגולגולת). בשל ריבוי הגורמים אי אפשר לומר באופן גורף שכאבי ראש משניים הם מסכני חיים.

כפי שאפשר לראות, לכאבי ראש גורמים רבים. על מטפלים במערך רפואת החירום לזהות גורמים מסכני חיים ולטפל בהתאם. כלומר עיקר הטיפול הוא שלילת נורות אזהרה.

נורות אזהרה בכאבי ראש

- כאב ראש פתאומי או כאב ראש חזק - התקף כאב ראש שמופיע בבת אחת, ללא התפתחות הדרגתית, מעורר חשד שיש דימום סאבארקנואיד (SAH)
- כאב ראש חדש במגמת החמרה - כאב ראש חדש, הנמשך כמה שבועות, עם מהלך של החמרה הדרגתית, מעורר חשד שיש תהליך תופס מקום כלשהו (גידול או דימום)
- כאב ראש על רקע חבלת ראש - ובייחוד אלו המלווים בבחילות והקאות
- כאב ראש עם סימני ICP - גם כאבים אלו מחשידים לתהליך תופס מקום, אך גם מנינגיטיס (דלקת קרום המוח, meningitis) עולה ב־DD. כאבים אלו כוללים:

- כאב ראש המעיר משינה
- כאב ראש המתגבר במאמץ
- כאב ראש בעל עוצמה מרבית בשעות הבוקר

- כאב ראש המלווה באחד מאלה:

- חום גבוה
- סימני גירוי מנינגיאליים
- פרכוסים
- שינויי התנהגות
- כפל ראייה או הפרעות ראייה אחרות
- חסכים נזירולוגיים אחרים (הפרעות מוטוריות או סנסוריות)

- כאב ראש חדש באוכלוסייה בסיכון

גם מטפלים עם רקע של כאבי ראש ראשוניים יכולים לסבול מתהליך תופס מקום, ולכן כאשר יש תלונה על תבנית כאב חדשה או שונה יש להתייחס לכך כאל כאב פרוגרסיבי.

אוכלוסיית סיכון בכאבי ראש

- אנשים שגילם מעל 50
- רקע רפואי הכולל לפחות אחד מאלה:
 - מחלה ממארת (סרטן)
 - AIDS
 - טיפול המדכא את מערכת החיסון
- כאב ראש חדש המופיע ב־postpartum period (שישה שבועות לאחר הלידה)
- הפרעה מיגרנוטית מעניינת נוספת היא סטטוס מיגרנוזוס (status migrainosus). זהו התקף מיגרנוטי האורך יותר מ־72 שעות, הוא חמור באופיו ומגביל. לעיתים קרובות התקף שכזה נובע ממינון יתר של תרופות אנטי־מיגרנוטיות.

כאבים בצוואר

תלונה על כאבים בצוואר היא תלונה נפוצה אם כי לא כמו כאבי ראש, כאבי בטן או כאבי גב. הגורמים העיקריים לכאבים אלו הם גורמים מיופציאליים (שריריים, myofascial). עם זאת, יש גורמים נוספים שעלולים להוביל לכאבים באזור זה, כגון גורמים שבהם מעורב עמוד השדרה וחוט השדרה. כמעט כל הכאבים האלה אינם מסכני חיים, ומטופלים תמיד בקהילה.

המקרים היחידים שבהם כאבים בצוואר מחשידים לאירוע מסכן חיים הם:

- אטיולוגיה טראומטית לצוואר
- אטיולוגיה קרדיאלית עם הקרנה לצוואר

טראומה לצוואר היא אתגר קליני. יש בצוואר מבנים אנטומיים רבים: שרירים, עמוד השדרה, חוט השדרה, קנה הנשימה, ושת, בלוטת התריס, כלי דם גדולים ומבנים לימפטיים. טראומה לאזור מסוכנת במיוחד בשל הפגיעה האפשרית בנתיב האוויר. מטופל שסובל מקוצר נשימה, צרידות, כאבים במגמת החמרה או שיש לו המטומה מתרחבת בצוואר, צריך להגיע ללא דיחוי לחדר מיון כדי לשלוט בנתיב האוויר. בשטח כדאי לשקול ביצוע אינטובציה (ואף קוניוטומיה), אך יש לזכור שבמצב זה שבו המבנה האנטומי פגוע מדובר בפרוצדורות מורכבות שנוטות להסתבך. לכן, אם אפשר, משאירים החלטה זאת לצוות בית החולים.

כאבים אנגינטיים לעיתים מקרינים לאזור הצוואר והלסת. בכל מטופל שמלין על כאבים חריגים באזור יש לחשוד ב־ACS.